Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51)3098-5389 - https://www.tjrs.jus.br/ - Email: frcanoas2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004939-15.2024.8.21.0008/RS

AUTOR: ADRIANA DUTRA AMARAL

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos.

ADRIANA DUTRA AMARAL ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, narrando, em síntese, que é beneficiária do plano Sulamérica Saúde, cartão de identificação nº 88888 4740 7072 0023, possuindo cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica. Relatou que é portadora de câncer de mama (CID 10 C 50.9), e que sua médica oncologista assistente solicitou que iniciasse tratamento com a medicação ABEMACICLIBE 150mg, com a ministração de 01 (um) comprimido via oral de 12/12 horas, continuamente, durante dois anos ou antes do desfecho clínico como progressão de doença ou toxicidade inaceitável. Argumentou que o fornecimento da medicação fora formalizado perante a operadora, entretanto, sobreveio negativa administrativa. Referiu que a ré somente disponibiliza as drogas correspondentes à terapia endócrina para uso pela médica assistente, negando-se a autorizar o fornecimento da droga ABEMACICLIBE, ainda que haja indicação expressa em bula para esta associação e a paciente se enquadre em todos os critérios para uso da terapia. Afirmou que houve o esgotamento dos tratamentos para o enfrentamento da sua enfermidade, sendo imprescindível a utilização do fármaco como alternativa terapêutica. Teceu considerações sobre o direito que entende aplicável. Em tutela de urgência, postulou o imediato fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, pelo período de dois anos ou antes do desfecho clínico como progressão de doença ou toxicidade inaceitável. Ao fundo, pugnou pela procedência do pedido para confirmar o pleito antecipatório deferido. Requereu a AJG. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Foi concedida a gratuidade da justiça à autora e deferida a tutela de urgência (evento 3, DESPADEC1).

O demandado interpôs agravo de instrumento, tendo sido negado provimento ao recurso pelo TJ/RS (processo 5084327-40.2024.8.21.7000/TJRS, evento 22, RELVOTO1).

Citada, a ré ofertou contestação no evento 12, CONT1, e informou o cumprimento da liminar. Impugnou o valor da causa. No mérito, discorreu sobre a taxatividade do rol da ANS. Afirmou que há cobertura para o medicamento Abemaciclibe tão somente para os casos específicos dispostos na Diretriz de Utilização nº 64 do anexo II do Rol da ANS vigente. Defendeu a legitimidade da negativa de cobertura. Indicou o direito que entende aplicável. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Indeferido o encaminhamento dos autos ao E-NATJUS e oportunizada a produção de provas (evento 31, DESPADEC1).

A ré não manifestou interesse na produção de prova pericial (evento 34, PET1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

PASSO A DECIDIR.

Do julgamento antecipado. A demanda comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Da impugnação ao valor da causa. Com efeito, assiste razão à demandada para ser retificado o valor da causa, porquanto este deve corresponder a uma anuidade do medicamento perseguido pela parte autora.

O orçamento do evento 1, OUT22, ilustra o custo mensal de R$ 25.897,87, razão pela qual o valor da causa deverá expressar a quantia de R$ 310.774,44.

Do mérito. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a paciente busca autorização do plano de saúde para realização de tratamento com medicação *ABEMACICLIBE 150mg* necessária para o combate da enfermidade de câncer de mama, a qual foi negada sob o seguinte argumento (evento 1, CERTNEG11):

Dados da Solicitação

Código na Operadora 100000021104	Referenciado 4 BIO MEDICAMENTOS S.A		CNES 0000000
Nº da Guia 156597844	Nº da Guia Principal	Nº da Guia no Prestador	Data da Solicitação 15/01/2024
Senha		Data da Autorização da VPP	Data de Validade da VPP
Status Negado	Descrição do Motivo 1438 - PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO ATENDER A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS		

Dados do Beneficiário (Segurado)

Nome ADRIANA DUTRA AMARAL	Data de Nascimento 24/02/1977	Sexo Feminino	Recém Nato Não
Plano ESPECIAL 100	Produto 545 - EMPRESARIAL AMB HOSP C OBST ADAPTADO		
Carteira do Beneficiário 545 88888 4740 7072 0023			

A prova documental coligida é suficiente para demonstrar que a paciente suporta enfermidade grave e os laudos médicos foram elaborados de forma pormenorizada pela médica assistente justificando a necessidade do tratamento (evento 1, LAUDO9).

Posto isso, importa consignar que em tal relação a demandada é fornecedora de serviço e a requerente é consumidora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2.º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3.º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem com os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2.º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Nesse caminho, como a negativa vem comprovada pelo documento constante do evento 1, CERTNEG11, além das razões de contestação da requerida, tem-se como ponto controverso a existência de cobertura ou não para o fornecimento do medicamento em desacordo com as "diretrizes de utilização".

O medicamento *ABEMACICLIBE 150mg* está listado na DUT n. 64 dentre aqueles quimioterápicos que possuem cobertura obrigatória (*https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_RN588.pdf*):

64. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER

SUBSTÂNCIA	LOCALIZAÇÃO	INDICAÇÃO
Abemaciclibe	Mama	Tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo): - em combinação com um inibidor da aromatase como terapia endócrina inicial; - em combinação com fulvestranto como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina; - como agente único, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para doença metastática. (Incluído pela RN nº 477, a partir de 14/01/2022)

Registre-se que o plano de saúde pode determinar quais doenças terão cobertura, mas não pode limitar as formas de tratamento indicadas pelo médico, mesmo que não previstas nas diretrizes de utilização da ANS - DUT N. 64.

Imperioso mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, cujo relator foi o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (Recurso Especial nº 668.216 – SP 2004/0099909-0):

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

*1. **O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta.***

2. Recurso especial conhecido e provido.

Do corpo do acórdão se extrai o seguinte fragmento:

" (...) a cláusula de exclusão rompe o equilíbrio contratual e causa vantagem exagerada em favor da ré "colocando o segurado em posição de excessiva onerosidade, já que não pode dispor dos benefícios pelos quais pagou, deve tal cláusula ser declarada nula, condenando-se a ré a pagar todas as despesas feitas no tratamento (...)

A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. ***Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato.*** *Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto* ***quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.*** *Além de representar severo risco para a vida do consumidor. Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02).* ***Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.*** *Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença.* ***Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.***

Assim, no caso, não havendo exclusão do câncer na apólice do autor, não há como impedir a cobertura do seguro para o tratamento por quimioterapia em regime ambulatorial ou de internação " (grifei).

No caso dos autos não estamos falando de medicamentos experimentais, mas de fármacos devidamente aprovados pela ANVISA. *In casu*, não se está diante de simples experimentação de fármaco, mas sim de **ampliação do espectro de eficácia de medicamento** reconhecido pela agência reguladora.

Daí é possível concluir que a negativa apresentada pela ré é inválida e injusta, pois o tratamento de paciente sempre deve ser orientado pela melhor alternativa terapêutica indicada pelo médico assistente para a doença a que está acometido.

Assim, interpreta-se as cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que por inteligência da Súmula nº 608 do STJ aplica-se a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Dessa forma, ante a previsão de cobertura do plano para a enfermidade da parte autora, é dever da requerida fornecer o tratamento recomendado pelo médico, já que diretamente relacionado à patologia.

Não destoa desse entendimento o informativo de jurisprudência nº 632 do STJ que já tratou em suas decisões sobre o tema:

A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). STJ. 3ª Turma. REsp 1721705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632).

Nesse sentido, recolho precedente do eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ***SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CARCINOMA MAMÁRIO. ABEMACICLIBE****. ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. DEVER DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, § 2°, DO CPC. - Em que pese a alegação de que o contrato de plano de saúde possa prever cláusulas limitativas acerca da cobertura, mostra-se abusiva a exclusão dos tratamentos e materiais necessários para o melhor desempenho clínico do paciente, quando indicados pelo médico que o acompanha, e destinados à cura de doença efetivamente coberta. -* ***Restou evidenciado nos autos a necessidade do tratamento com a medicação ABEMACICLIBE a parte autora, conforme indicação do seu médico assistente. Tratando-se de medicamento antineoplásico.*** *- Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados de forma equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, em atenção ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1076 do STJ. Sentença reformada no ponto, a fim de arbitrá-los com base o §2º do art. 85 do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA.(Apelação Cível, Nº 50037761220238210080, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 28-11-2024) [grifei]*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. *DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. Obrigação de fazer.* ***Fornecimento dos medicamentos Abemaciclibe 150 mg via oral 12/12 horas. Tratamento de câncer de mama. Em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo, não podendo ser exigidos das operadoras de plano de saúde, portanto, a cobertura dos tratamentos ali não previstos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no entanto, admite mitigações, sobretudo após alterações da Lei nº 14.454/2022.*** *Caso dos autos em que o autor foi diagnosticado com "Câncer de mara", razão pela qual necessita fazer uso do tratamento do medicamento Abemaciclibe 150 mg. Com efeito, o artigo 12 da Lei nº 9.656/98 elencou os medicamentos antineoplásicos dentre as coberturas obrigatórias, ainda que para tratamento domiciliar. Tampouco a alegação de que a negativa de cobertura teve por fundamento o uso off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento) merece prosperar, uma vez que é considerada abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). Entendimento do STJ. Assim, é devido o fornecimento do medicamento. Danos morais. Não obstante esteja assegurado o direito ao fornecimento da medicação, a negativa administrativa por parte do plano de saúde não se reputa abusiva, a ponto de ensejar a indenização por danos morais, uma vez que baseada em interpretação das normas da ANS que regulam a matéria. No caso dos autos, a parte autora não logrou demonstrou que a negativa de cobertura lhe causou sofrimento extraordinário, não se tratando de dano moral in re ipsa. Precedentes desta Câmara. Honorários advocatícios. Recurso que vai parcialmente provido, a fim de majorar os honorários fixados na origem, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ UNIMED E DERAL PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. (Apelação Cível, Nº 50002323220248211001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-02-2025) [grifei]*

Por fim, o princípio da boa-fé deve reger toda a relação contratual, tal como preceitua o art. 422 do CC, não sendo plausível uma doença que possui cobertura pelo plano de saúde contratado ter o tratamento negado por interpretações restritivas da lei e das próprias cláusulas contratuais, em especial quando há risco iminente à vida da paciente.

Assim, prospera a pretensão de obrigação de fazer.

Diante do exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos movidos por ADRIANA DUTRA AMARALcontra **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,** para tornar definitiva a tutela provisória deferida no evento 3, DESPADEC1, devendo o tratamento ser adequado ao laudo do evento 1, LAUDO9, ou outro que sobrevier para enfrentamento da mesma doença.

Em razão da sucumbência, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, CPC, considerando o tempo de tramitação, o grau de zelo empregado pelo causídico e a natureza e importância da causa.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, baixe-se em definitivo.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA RECHDEN LOBATO, Juíza de Direito**, em 14/04/2025, às 21:41:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10080519324v9** e o código CRC **4f7e1dd1**.